SENTENÇA

Processo: 0802755-41.2024.8.19.0026

Classe: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135)

AUTOR: NORMA GUILHERMINA LACERDA DA FONSECA

RÉU: UNIMED DO NORTE FLUMINENSE COOP TRABALHO MEDICO

I RELATÓRIO

-

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAR COM CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA ajuizada por NORMA GUILHERMINA LACERDA DA FONSECA em face de UNIMED DO NORTE FLUMINENSE COOP. TRABALHO MÉDICO, todos já qualificados nos autos.

Ao ID. 118373886, petição inicial na qual a parte autora, nestes termos, narra os fatos:

> A autora é beneficiária do "plano de saúde" da Ré (Unimed Fácil Local Enfermaria), sob nº 077.7686.241001.00-6, conforme cópia da documentação anexa.
>
> Conforme detalhado no laudo médico anexo, a autora apresenta diagnostico de ASMA GRAVE – CID J45.0 – COM EVOLUÇÃO PROGRESSIVA E CONSEQUENTEMENTE PIORA DOS SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, COM DISPNEIA AOS MÍNIMOS ESFORÇOS, CHIEIRA TORÁCICA E TOSSE INTENSA. OCORRÊNCIA DE INÚMERAS INTERNAÇÕES EM CTI POR EXACERBAÇÃO DAS CRISES. APRESENTA AINDA, QUADRO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (HAS) E DIABETES MELLITUS TIPO 2 (DMT2).

(...)

De acordo com o laudo médico do profissional que lhe assiste, Dr. Luiz C. Bandoli, conceituado especialista em Alergia e Imunologia, mediante ao estado da autora em que infelizmente se manifesta de forma agressiva, este, determinou o início do tratamento com o medicamento TEZEPELUMABE da seguinte forma: Uso de TEZEPELUMABE 210 MG subcutânea de 4/4 semanas DE FORMA CONTÍNUA.

Há informação no laudo médico, que houve uma falha terapêutica com o uso do medicamento XOLAIR (medicamento fornecido pelo plano de saúde), tendo como ÚNICA alternativa disponível para o perfil da doença, a indicação do uso de TEZEPELUMABE, devido a autora ser paciente com risco de morte, inclusive, em unidades de terapia com risco de asma fatal.

Diante do grave quadro que se apresenta a autora, com risco de morte, e, portanto da urgência em fazer uso da medicação, foi solicitada autorização a ré, para a cobertura do medicamento indicado, sendo este NEGADO pela mesma, conforme documento anexo. Negativa esta justificando que "A INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS EM SAÚDE, BEM COMO A DEFINIÇÃO DE REGRAS PARA SUA UTILIZAÇÃO É DEFINIDA POR MEIO DE SUCESSIVOS PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE E, PROCEDIMENTOS AINDA NÃO INCLUÍDOS NO ROL PODERÃO SER AVALIADOS A PARTIR DE ESTUDOS CLÍNICOS QUE PACIENTES. SENDO ASSIM, COMUNICAMOS QUE APÓS REANÁLISE, MANTEREMOS A NEGATIVA CONFORME ACIMA EXPLICADO."

(...)

Cuida-se de negativa abusiva de cobertura contratual, com base em interpretação abusiva de cláusulas contratuais que o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor consideram nulas, uma vez que estabelecidas em detrimento do consumidor final, além do estado grave da autora, que mesmo com RISCO DE MORTE, teve seu pedido negado pela operadora de plano de saúde ré.

Face ao exposto, requer:

a) Diante do exposto, confia a autora em que V.Exa. concederá a tutela provisória de urgência ora requerida, inaudita altera parte, a fim de: I - Diante da relevância dos fundamentos da demanda, bem como do receio da consumação de prejuízos irreparáveis à esfera da saúde da autora, A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, inaudita altera pars, a fim de ordenar a operadora de plano de saúde Ré que forneça a autora, em 24 HORAS, tratamento com o medicamento TEZEPELUMABE da seguinte forma: Uso do TEZEPELUMABE 210MG – APLICAR VIA SUBCUTANEA A CADA 4 SEMANAS - DE FORMA CONTÍNUA, conforme prescrito pelo médico especialista, como consta em prescrição médica ou enquanto perdurar a necessidade de seu uso, garantindo-se, ainda, como única forma de garantir-lhe o direito à vida, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 5.000,00, (cinco mil reais) em caso de descumprimento; II - Determine que a Ré autorize eventuais e adicionais solicitações médicas que possam vir ocorrer durante o tratamento da autora, necessários no seu tratamento;

b) A concessão, em sentença, da segurança ora perseguida pela autora, confirmando-se os pedidos formulados acima, em sede e pedido liminar, conforme item (I) supra;

c) Seja a Ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

Ao ID. 118754378, decisão que defere a gratuidade de justiça à parte autora, bem como defere a tutela provisória de urgência nos termos em que requerida.

Ao ID. 122217916, a parte ré apresenta contestação, oportunidade na qual afirma que “o medicamento não preenche o requisito de que sua finalidade seja antineoplásico, sendo certo, que há afronta a previsão legal inserida no inciso VI do artigo 10 da Lei 9.656/98 quanto às vedações de cobertura assistencial”. Desse modo, o plano de saúde não estaria vinculado à cobertura de todos os procedimentos, intervenções ou medicamentos que o médico assistente prescreva. No mais, alega, genericamente, a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil. Por fim, pugna pela total improcedência da demanda.

Ao ID. 123003429, decisão em 2ª Instância deste Tribunal que defere o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela parte ré.

Ao ID. 128728387, a parte autora, em réplica, informa que não possui outras provas a produzir, além de impugnar, especificamente, as teses defensivas.

Ao ID. 155760522, negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte ré.

Ao ID. 155853423, decisão que reconhece a relação de consumo entre as partes e inverte o ônus da prova.

Ao ID. 178684277, decisão de saneamento e organização do processo que fixa como questão controversa a obrigação do réu em fornecer a medicação requerida pela autora na inicial, além de declarar encerrada a instrução processual.

Preclusa a decisão retro, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Passo a fundamentar e a decidir, nos termos preconizados pelo art. 93, inc. IX, da Constituição da República.

II FUNDAMENTAÇÃO

Inexistem questões processuais pendentes ou preliminares a serem analisadas. A seu turno, estão presentes os pressupostos processuais de existência e validade, assim como as condições para o exercício regular do direito de ação, positivadas no art. 17 do CPC (interesse e legitimidade).

Passo, pois, a examinar o mérito desta demanda.

De início, verifico que há relação de consumo entre as partes, eis que presentes os requisitos subjetivo e objetivo, nos termos dos artigos 2° e 3° do CDC.

A relação jurídica em questão se submete, pois, ao arcabouço normativo do Código de Defesa do Consumidor.

Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços é objetiva, pautada na teoria do risco do empreendimento, pelo que independe da comprovação de culpa e somente será afastada nos casos de excludentes do nexo de causalidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos moldes preconizados pelos artigos 12, 14, 18 e 20, todos do CDC.

Dessarte, a lei consumerista, especialmente em seu artigo 12, §3°; e artigo 14, §3°, estabelece hipótese de inversão do ônus da prova *ope legis*, cabendo ao próprio fornecedor de produtos e serviços demonstrar a regularidade de sua prestação.

Contudo, saliente-se que, não obstante a distribuição do ônus da prova e a responsabilidade objetiva supracitadas, cabe ao consumidor produzir provas mínimas de suas alegações fáticas.

Neste sentido, dispõe o enunciado de súmula n° 330 do TJRJ que "os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito".

Pois bem.

Conforme decisão saneadora de ID. 178684277, a questão controversa reside na obrigação do réu em fornecer a medicação requerida pela autora na inicial.

Em sua petição inicial de ID. 118373886, a parte autora alega necessitar do medicamento TEZEPELUMABE, porquanto - em razão do diagnóstico de asma grave, com evolução progressiva e consequente piora dos sintomas respiratórios, com dispneia aos mínimos esforços, chieira torácica e tosse intensa, além de hipertensão arterial e diabete melitus - seu médico assistente reputou não haver terapia alternativa.

De sua vez, a parte ré, em sua contestação de ID. 122217916, argumenta, em síntese, que a previsão do §13 do artigo 10 da Lei 9.656/98 não se aplica ao fornecimento de medicamento de uso domiciliar que não tenha indicação antineoplásica, face à vigência do *caput* do artigo 10 e seus incisos, todos da Lei 9.656/98, por não preencherem os requisitos descritos nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12 da mesma Lei.

Lançadas as teses autorais e defensivas, passo a ponderá-las.

A questão é simples. A parte autora, em verdade, não faz uso de medicação sob a modalidade de tratamento domiciliar. Isso porque basta atentar ao documento de ID. 128728396, no qual se vê termo de adesão ao programa de atendimento domiciliar no regime *home care*. Além disso, denoto, baseado no laudo de ID. 128730605, expressa autorização e recomendação de que o tratamento seja feito em ambiente hospitalar.

Aliás, transcrevo seu teor:

> Paciente com quadro de Asma grave (J45), em uso de Xolair 600 mg a cada 4 semanas, sem Faz uso melhora do do quadro. Faz uso ainda de Fostair 6/200 mcg, Spiriva, Montelair 10 mg. recorrente em altas doses de corticoide oral. Porém a paciente apresenta Hipertensao arterial sistêmica, pre-diabetes tipo 2 e obesidade. Sabemos que o uso crônico de corticoide oral pode complicar ainda mais tais comorbidades. Paciente 26/05/24. ganhou judicialmente o uso da medicação Tezspire. Fez uso de uma aplicação no dia É de extrema importância que a paciente continue o uso do medicamento para que a mesma tenha um melhor controle da doença. Sabemos que a asma quando não controlada pode matar, deixando assim a paciente sob o risco de vida caso não faça uso da medicação. A medicação deve ser aplicada por via subcutânea, e realizada num ambiente adequado e com a presença de profissionais de saúde treinados, para que em caso de maiores complicações possam intervir. Deve ser feito em ambiente hospitalar, assim como era no período que fez uso do Xolair.

Ante o exposto, o entendimento consolidado por nossa jurisprudência, especialmente pelo C. Superior Tribunal de Justiça, acolhe a pretensão autoral, vez que “é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os

incluídos no Rol da ANS para esse fim (arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 - atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021).”

Em mesma orientação, destaco alguns precedentes da referida corte, vejamos:

> AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FÁRMACO À BASE CANABIDIOL. MEDICAMENTO. ANVISA. REGISTRO. AUSÊNCIA. IMPORTAÇÃO. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL. DISTINGUISHING. DEVER DE COBERTURA. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. DESCARACTERIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. SITUAÇÃO. HOME CARE. CONVERSÃO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. 1. As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela Anvisa (Tema Repetitivo nº 990 do STJ). 2. Em caso de medicamento sem registro cuja importação foi autorizada pela Anvisa, a exemplo de fármaco à base de canabidiol, este Tribunal Superior tem promovido o distinguishing. 3. A autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio do paciente, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei nº 6.437/1977 e art. 12, c/c art. 66, da Lei nº 6.360/1976. 4. **É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim (arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 - atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)**. 5. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada

como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida). 6. Na hipótese, a autora encontrava-se em home care, atenção à saúde concedida em substituição à internação hospitalar, de modo que a medicação prescrita nesse estado de internação, mesmo sendo uma "solução oral", deve ser coberta pelo plano de saúde, não se caracterizando, no caso, o simples "uso domiciliar", ao contrário, é uma substituição do ambiente hospitalar em que o fármaco estaria sendo custeado (medicação assistida). 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.873.491/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. MEDICAMENTO INJETÁVEL. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há violação do art. 1.022 do CPC. 2. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Precedentes. 3. Hipótese em que o medicamento é injetável subcutâneo. "A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)." (AgInt no REsp n. 1.873.491/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.108.874/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Desse modo, a situação trazida pela parte autora, corroborada pelos documentos que instruem suas alegações iniciais, se enquadra na hipótese especial que obriga o fornecimento do medicamento pela operadora do plano de saúde.

Assinalo, oportunamente, este entendimento:

> DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LÚPUS ERITEMATOSO. PIELONEFRITE. RITUXIMABE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. USO OFF-LABEL. REGISTRO NA ANVISA. MEDICAÇÃO ASSISTIDA. APLICAÇÃO POR PROFISSIONAL HABILITADO. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021). 2. **A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)"** (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022)

Assim, procede o pleito autoral de que a ré seja obrigada a custear o fornecimento do medicamento TEZEPELUMABE 210mg, com aplicação via subcutânea a cada 4 semanas, de forma contínua. Razão pela qual TORNO DEFINITIVA a tutela provisória de urgência deferida no ID. 118754378.

No tocante à compensação por danos morais, saliente-se que se trata de modalidade de dano atualmente compreendida como decorrência de lesões a direitos da personalidade, independendo, para sua configuração, de prova de sentimentos humanos desagradáveis.

Trata-se da teoria objetiva do dano moral, segundo a qual os estados físicosou psíquicos eventualmente experimentados pelo indivíduo são apenas consequências da lesão, mas não o dano em si.

Neste sentido, o Enunciado n° 445 do CJF: “o dano moral indenizável não pressupõe necessariamente a verificação de sentimentos humanos desagradáveis, como dor ou sofrimento”.

Especificamente quanto à recusa indevida no fornecimento de medicamentos, este E. Tribunal de Justiça editou os enunciados de súmulas 209 e 339, nestes moldes:

> SUMULA TJ Nº 209 "enseja dano moral a indevida recusa de internação ou serviços hospitalares, inclusive *home care*, por parte do seguro saúde somente obtidos mediante decisão judicial."

> SUMULA TJ Nº 339 "a recusa indevida ou injustificada, pela operadora de plano de saúde, de autorizar a cobertura financeira de tratamento médico enseja reparação a título de dano moral."

Em mesma direção, precedente deste Tribunal:

> APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO "REVOLADE" PARA TRATAMENTO DE EFEITOS ADVERSOS DECORRENTES DE DOENÇA ONCOLÓGICA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO PLANO DE SAÚDE RÉU. Laudo médico que atesta quadro de linfoma T angioimunoblástico, com indicação do uso do medicamento Revolade

(Eltrombopague) para controle e estabilização dos níveis plaquetários, a fim de viabilizar a continuidade do tratamento de saúde da parte autora. Trata-se de fornecimento de medicamento destinado a combater efeitos adversos decorrentes de doença oncológica, devendo, portanto, ser considerado como parte do tratamento do câncer em regime ambulatorial. Medicação classificada como continuidade da terapia antineoplásica, cuja cobertura é obrigatória, nos termos do art. 16, parágrafo único, da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS. Medicamento que possui registro pela ANVISA, sendo certo que, segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no AREsp 1.653.706/SP). Obrigatoriedade da cobertura do medicamento antineoplásico oral prescrito pelo médico assistente, não havendo que se falar em exclusão com base no rol da ANS quando se trata de tratamento do câncer. Abusividade da negativa. Danos morais configurados in re ipsa. Aplicação da Súmula 339 do TJRJ. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à média fixada por esta E. Corte de Justiça em casos semelhantes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (0804841-24.2024.8.19.0207 - APELAÇÃO. Des(a). FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO - Julgamento: 14/08/2025 - VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 19ª CÂMARA CÍVEL)

No caso em apreço, vejo que a parte autora foi submetida a nítido abalo psíquico, sendo necessário recorrer ao Poder Judiciário para ter seus direitos assegurados, o que, evidentemente, prolongou a espera por tratamento que deveria lhe ter sido concedido no momento em que requerido.

Assim, a autora deve ser compensada a título de danos morais.

A fixação do valor compensatório deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, à luz das circunstâncias do caso concreto.

Reputo, assim, que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende a tais requisitos, considerando a gravidade do fato em si e a culpabilidade do agente.

III DISPOSITIVO

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para **CONDENAR** a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação por danos morais, com incidência de correção monetária pelo IPCA a partir da data desta sentença (Súmula n° 362 do STJ e súmula n° 97 do TJERJ) e juros de mora pela taxa legal, correspondente à SELIC, deduzida a variação correspondente do IPCA (art. 406, §1º, do CC), desde a citação (art. 405 do CC).

CONFIRMO a tutela provisória de urgência deferida na decisão de ID. 118754378

Tendo em vista o entendimento jurisprudencial cristalizado na súmula nº 326 do STJ, condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado e nada mais sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se.

ITAPERUNA, data da assinatura digital.

HENRIQUE GONCALVES FERREIRA
Juiz Titular

Assinado eletronicamente por: **HENRIQUE GONCALVES FERREIRA**
21/08/2025 15:58:10
https://tjrj.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

25082115581029800000207772000

IMPRIMIR GERAR PDF